

Schwannoma Colônico

Tumor Raro Diagnosticado por Ecoendoscopia — **Importância do diagnóstico pré-operatório**

CASO CLÍNICO

ECOENDOSCOPIA





DEFINIÇÃO

O que é Schwannoma?

→ Origem Neural

Derivado das células de Schwann da bainha de mielina

→ Comportamento

Geralmente **benigno**, crescimento lento

→ Localização TGI

Incomum no trato gastrointestinal

Distribuição no Trato GI

<1%

Tumores GI

Proporção de schwannomas entre neoplasias gastrointestinais

60+

Idade típica

Predomínio após a sexta década de vida

1:1

Sexo

Sem predileção por sexo — acomete igualmente H e M

- ❏ Estômago é o sítio mais comum; **acometimento colônico é raro** e pouco descrito na literatura.



APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Frequentement e Silencioso

A maioria dos casos é **achado incidental** em colonoscopia de rastreio.

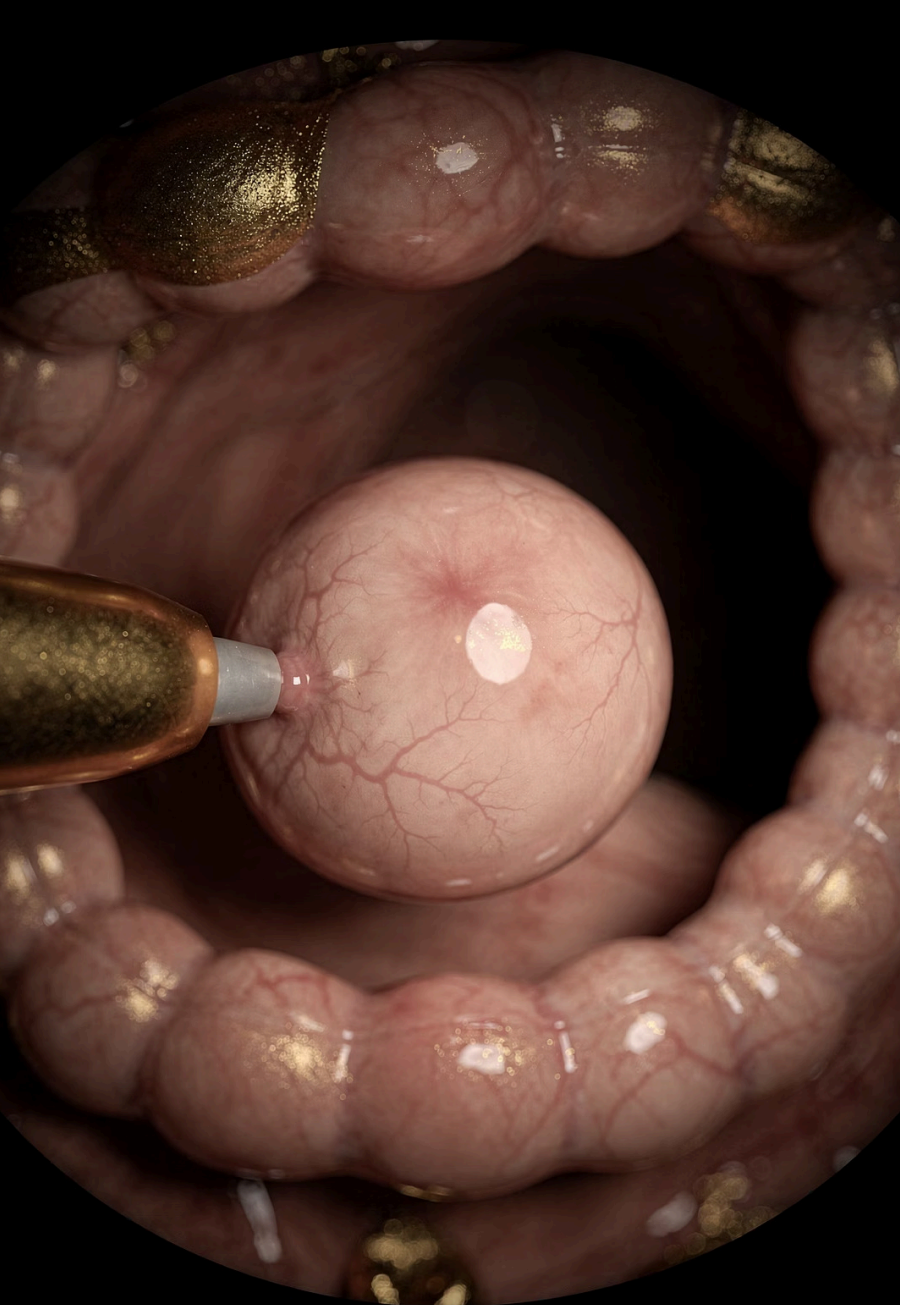
Dor abdominal

Constipação

Tenesmo

Sangramento





ENDOSCOPIA

Achados Colonoscópicos

Lesão Subepitelial

Mucosa íntegra recobre a lesão

Formato Regular

Bem delimitada, bordas lisas

Ulceração

Pode ocorrer em lesões maiores

Apresentação do Caso

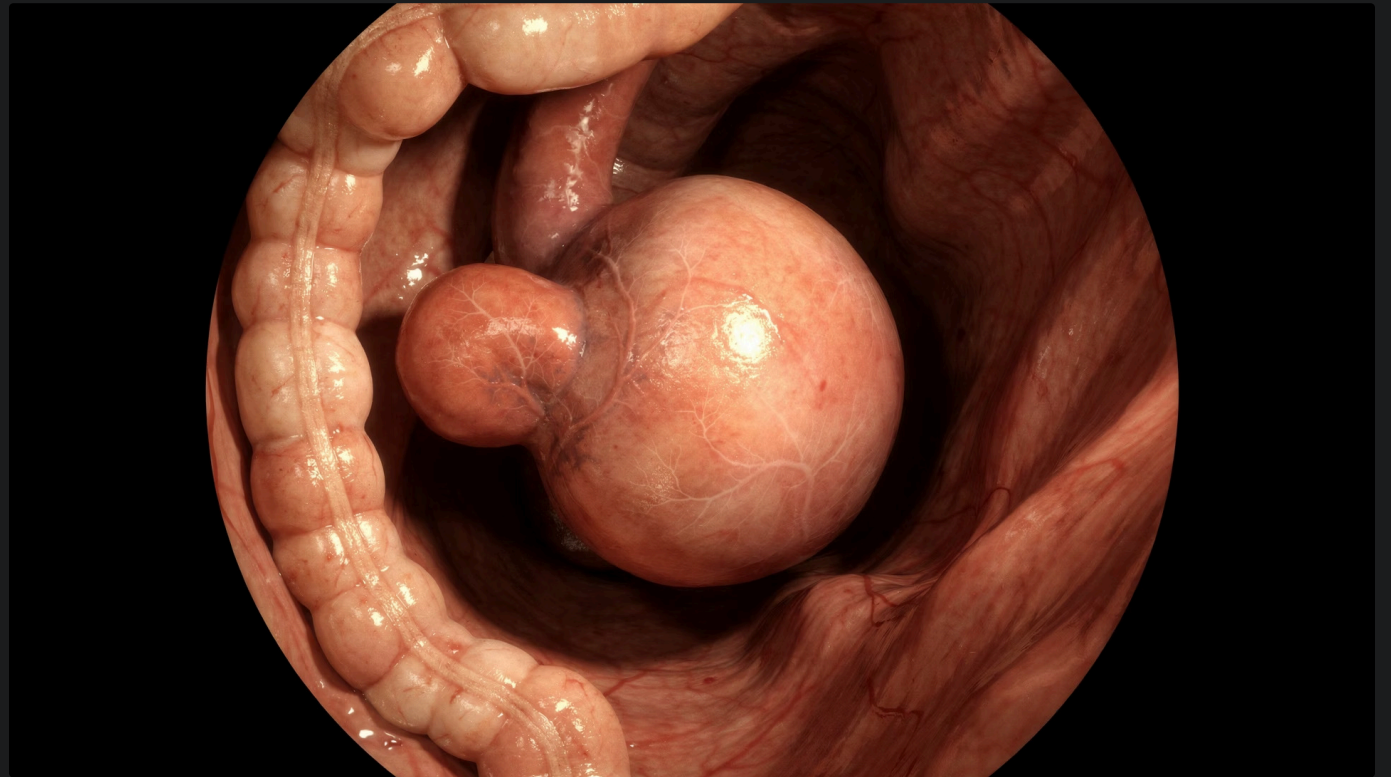
Dados da Paciente

Feminina, 73 anos

Colonoscopia de rotina — assintomática

Achado Endoscópico

- Lesão elevada séssil
- Dimensão: **30 mm**
- Localização: **cólon ascendente**
- Mucosa íntegra, sem ulceração



CASO CLÍNICO

Ecoendoscopia



Ecogenicidade

Lesão **hipoecoica**, homogênea

Dimensão

27 × 26 mm — quase esférica

Camada de Origem

Muscular própria (4^a camada)

Limites

Bem definidos, sem invasão
adjacente



CASO CLÍNICO

Punção Guiada por Ecoendoscopia

Técnica

- Agulha **22G FNB**
- Múltiplas passagens
- Material adequado para imunoistoquímica

Resultado Citológico

Neoplasia Fusocelular

Células fusiformes, sem atipias significativas

Baixo Grau

Baixo índice mitótico

TRATAMENTO

Colectomia Direita Videolaparoscó pica

Ressecção completa da lesão com
margens livres.

01

Indicação Cirúrgica

Lesão > 20 mm, origem em muscular
própria

02

Abordagem

Videolaparoscopia — menos invasiva

03

Resultado

Ressecção R0 — margens livres
confirmadas



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Imunoistoquímica — Confirmação

S100

Positivo ✓ — confirma origem neural



C-KIT (CD117)

Negativo — exclui GIST



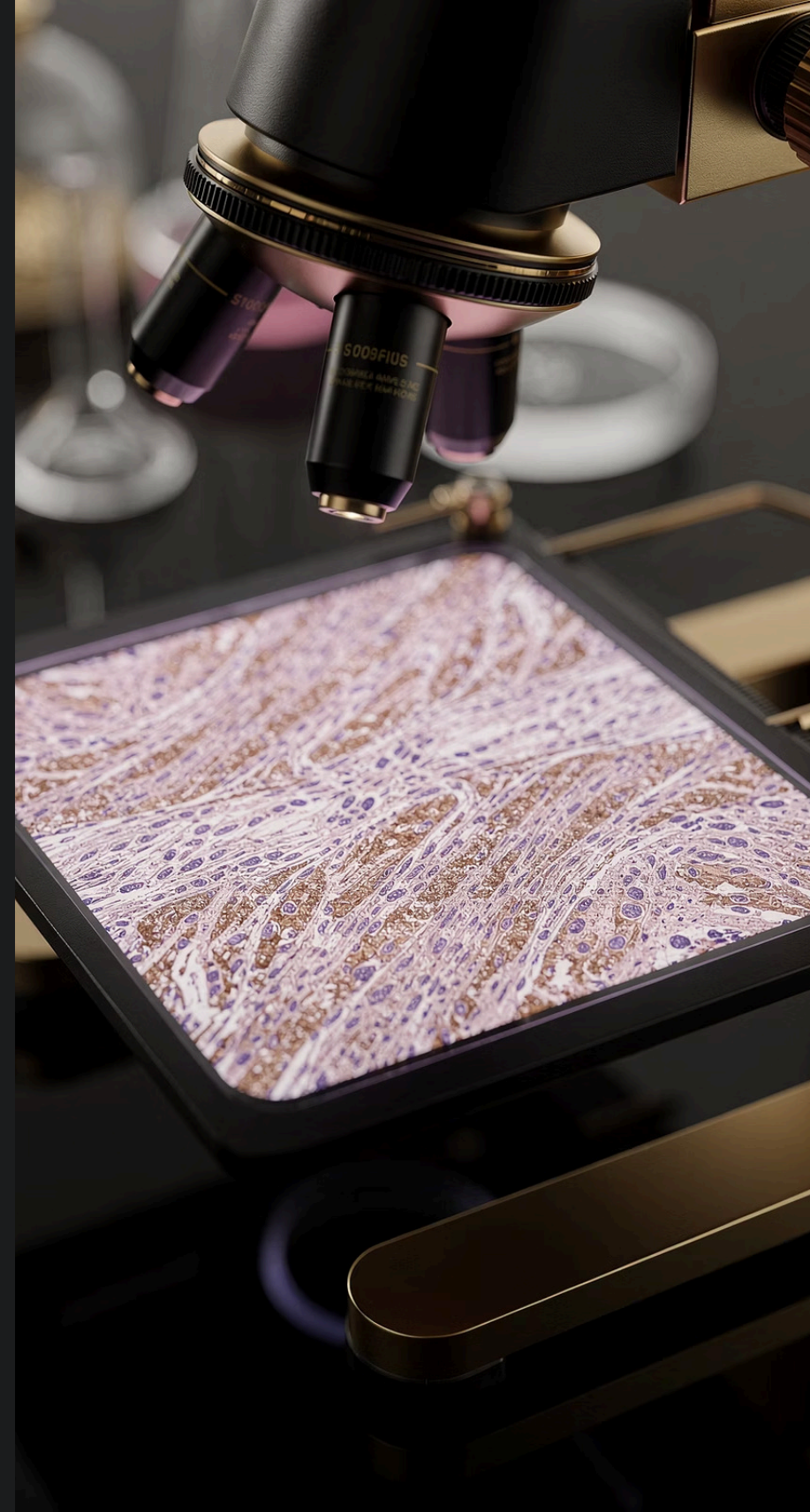
DOG-1

Negativo — exclui GIST

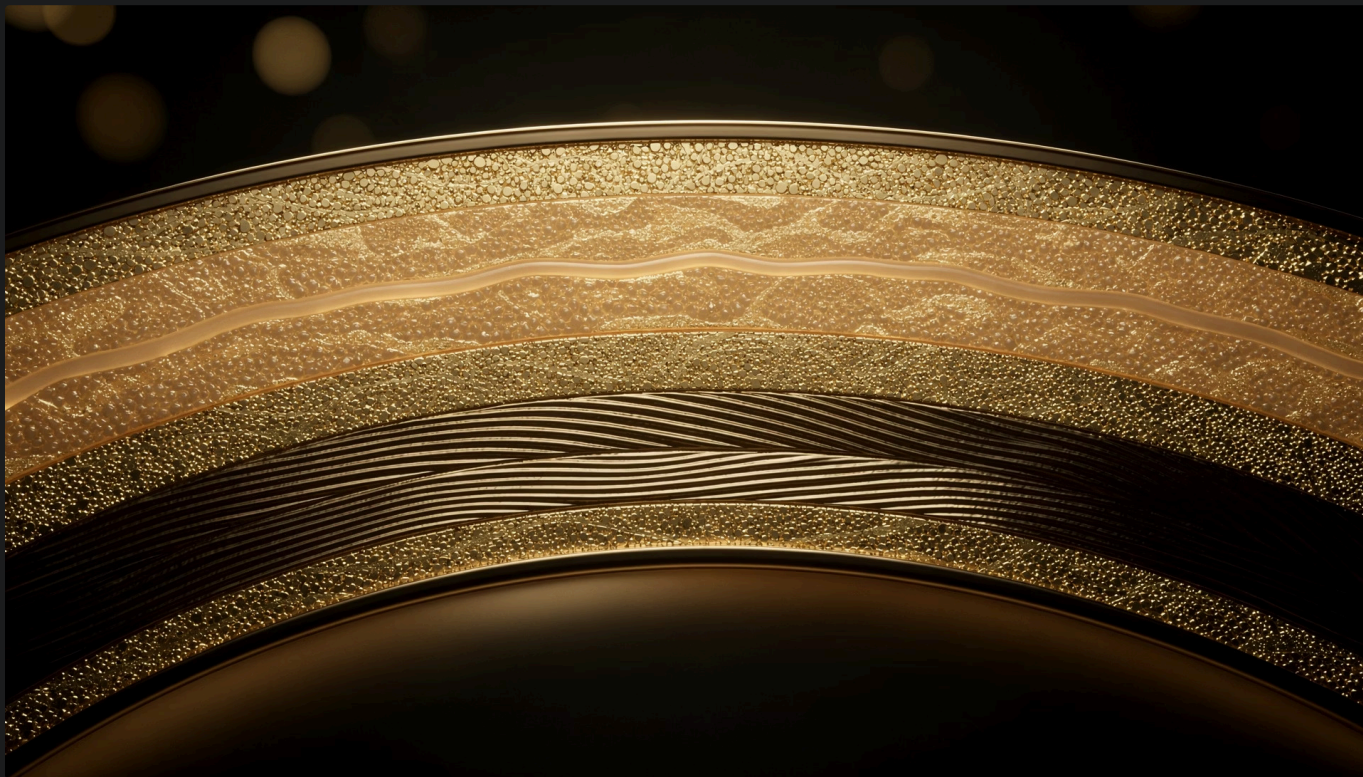


CD34

Negativo — exclui GIST e leiomioma



Por Que a Ecoendoscopia é Essencial?



Camada de Origem

Identifica com precisão a camada comprometida



Punção Diagnóstica

Permite coleta de material para imunoistoquímica

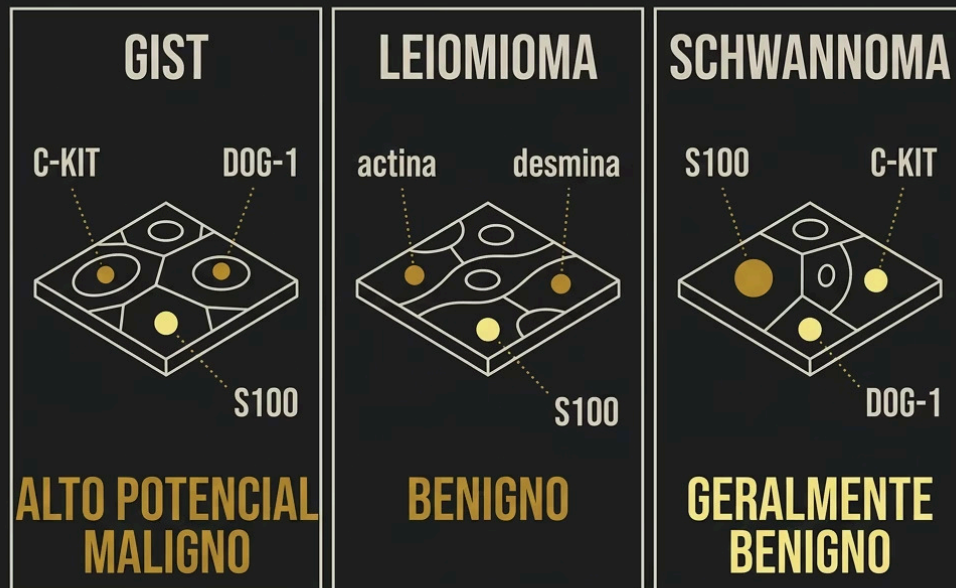


Planejamento Cirúrgico

Define a melhor abordagem operatória

Desafio: Lesões Subepiteliais

As lesões subepiteliais são visualmente semelhantes à colonoscopia. A ecoendoscopia e a imunoistoquímica são essenciais para diferenciá-las.



GIST

Mais comum — C-KIT e DOG-1 positivos.
Potencial maligno variável.

Leiomioma

Actina e desmina positivos. Sem risco oncológico.

Lipoma

Hiperecoico na EUS — fácil diferenciação.

Schwannoma

S100 positivo — diagnóstico definitivo por IHQ.



PEÇA CIRÚRGICA

Espécime Pós-Ressecção

Tumor Encapsulado

Limites bem definidos,
pseudocápsula presente

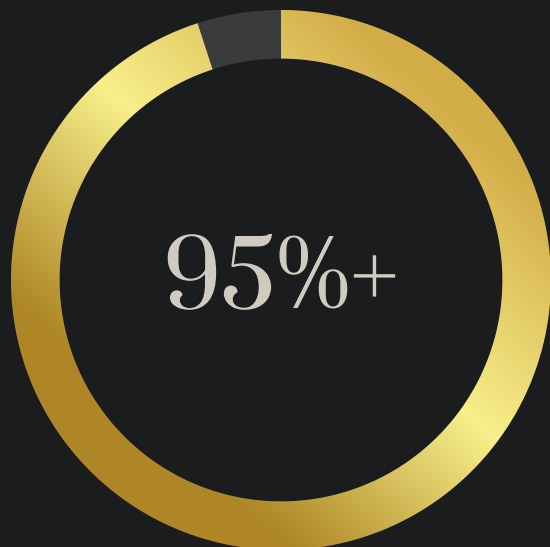
Margens Livres

Ressecção R0 confirmada

Sem Necrose

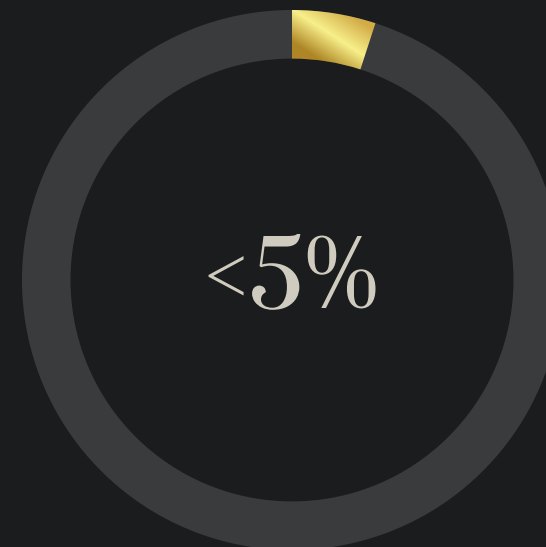
Sem sinais de agressividade histológica

Evolução Favorável



Sobrevida

Taxa de sobrevivência em 5 anos após ressecção completa



Recorrência

Risco de recidiva local após R0

Conduta Pós-Operatória

→ Ressecção Completa

Tratamento padrão e definitivo

→ Seguimento Clínico

Colonoscopia e imagem
periódicas

→ Sem Quimioterapia

Não indicada para tumores
benignos ressecados

TAKE HOME MESSAGE

Conclusões Essenciais



Schwannoma Colônico é Raro

Pensar nele diante de lesão subepitelial S100+



Ecoendoscopia é Indispensável

Define camada, morfologia e permite punção diagnóstica



IHQ Define o Diagnóstico

S100(+), C-KIT(-), DOG-1(-) = Schwannoma



Ressecção = Cura

Excelente prognóstico com cirurgia completa

